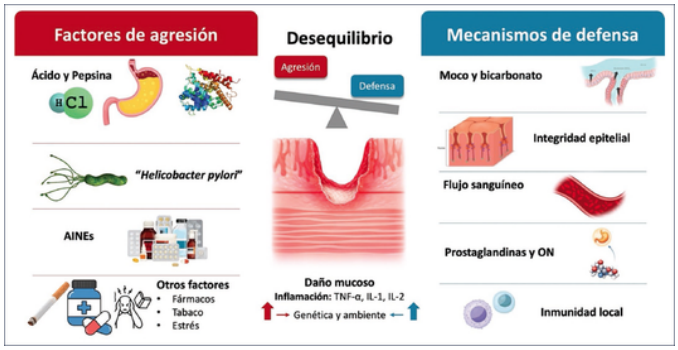
# ENFERMEDAD ÚLCERO-PÉPTICA Y TUMORES BENIGNOS DE ESTOMAGO

DR. ALFREDO MATOS

## ENFERMEDAD ÚLCERO-PÉPTICA

- Causas principales: infección por H. pylori y uso de AINEs; menos frecuente, el síndrome de Zollinger-Ellison (gastrinoma).
- Úlcera duodenal: la más frecuente, el dolor mejora con la comida. Úlcera gástrica: el dolor puede empeorar con la comida; siempre biopsiar para descartar malignidad.
- Complicaciones: sangrado, perforación y obstrucción (por edema o cicatrización pilórica).




## HELICOBACTER PYLORI

- Gram negativo; causa el 90% de las úlceras duodenales y el 75% de las gástricas.
- Estándar de oro: histología por biopsia endoscópica (H-E o plata).

## AINES

- Los inhibidores selectivos de COX-2 (celecoxib, etoricoxib) reducen el riesgo de úlcera gástrica un 79% y duodenal un 62% frente a los no selectivos.

## PERFORACIÓN

- Peritonitis química y dolor epigástrico agudo; neumoperitoneo en el 85% en la Rx de tórax de pie.
- Cirugía: biopsia obligatoria de los bordes (descartar adenocarcinoma) y cierre con parche de Graham.

## HEMORRAGIA

- Complicación más frecuente.

## OBSTRUCCIÓN (SÍNDROME PILÓRICO)

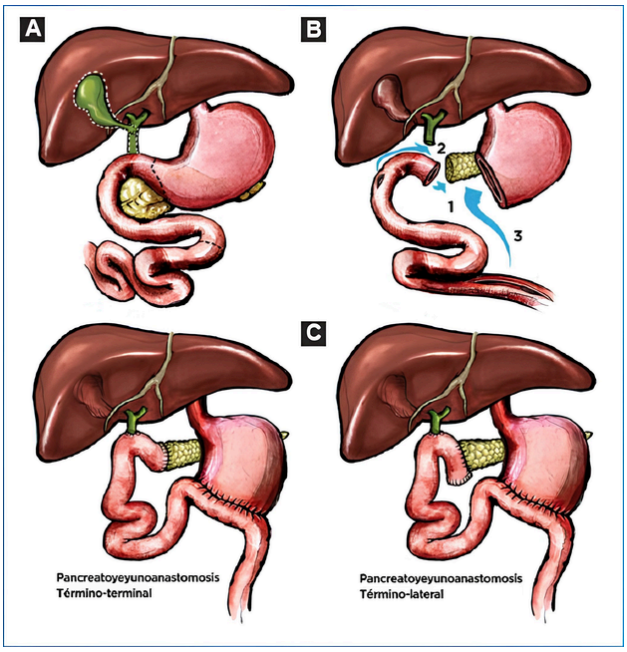
- Por inflamación y cicatrización crónica retráctil del bulbo/píloro.

## VAGOTOMÍAS

- Troncular, selectiva o ultraselectiva.

## RECONSTRUCCIONES

- Billroth I (gastroduodenal), Billroth II (gastroyeyunal) o gastrectomía total con esofagoyeyunoanastomosis en Y de Roux.




## TRATAMIENTO

- Inhibidores de bomba de protones (IBP) como base del tratamiento.
- Erradicación de H. pylori: esquema triple o cuádruple con antibióticos e IBP.
- Cirugía: reservada para complicaciones (perforación, sangrado no controlado por endoscopia, obstrucción).

# ENFERMEDAD ÚLCERO-PÉPTICA Y TUMORES BENIGNOS DE ESTOMAGO

DR. ALFREDO MATOS

**TUMORES BENIGNOS DE ESTÓMAGO**

- Pólipos hiperplásicos: los más frecuentes; bajo potencial maligno.
- Pólipos adenomatosos: mayor riesgo de malignización; requieren resección y seguimiento.
- Pólipos de glándulas fúndicas: asociados al uso crónico de IBP; casi nunca malignos.

**GIST Y LEIOMIOMA**

- GIST (tumor del estroma gastrointestinal): se origina de las células intersticiales de Cajal; el riesgo depende del tamaño y el índice mitótico.
- Leiomioma: tumor benigno de músculo liso, generalmente asintomático y hallazgo incidental.
- Los tumores submucosos sintomáticos o de riesgo se tratan con resección quirúrgica.

**SEGUIMIENTO DE LOS PÓLIPOS GÁSTRICOS**

- Los pólipos mayores de 1 cm o de tipo adenomatoso se resecan por endoscopia y se envían a patología.
- El seguimiento endoscópico depende del tipo histológico y el tamaño del pólipo.
- Los pólipos hiperplásicos mayores de 1 cm también deben resecarse por el riesgo de sangrado.

